



ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР РАДІОХІРУРГІЇ



ВІДДІЛЕННЯ ПЕТ-КТ ДІАГНОСТИКИ

Пацієнт: Жерліцина Анастасія Станіславівна, 1976 р.н.

ПЕТ/КТ всього тіла з контрастним підсиленням

2026.06.19 / #53478/25

Внутрішньовенно введено F18ДГ - 232.7 МБк, кат. - АД, ефективна доза ПЕТ - 4.4000001 мЗв, КТ - 18.700001 мЗв

Протокол дослідження:

Клінічні дані:

1. Гастроінтестинальна стромальна пухлина (GIST) шлунку, метастаз GIST в печінку (CSD). Стан після EUS-FNA біопсії шлунку, core-біопсії печінки.

08.2023 - стан після 4-х місяців лікування Іматинібом. 03.2025 - стан після 2х років лікування Іматинібом з позитивною клінічною картиною. Після останнього ПЕТ-КТ продовжено щоденний прийом Іматинібом (Глівек).

2. Лейоміосаркома тіла матки T2NxM1, вторинне ураження печінки, очеревини. Стан після 4-х курсів ХТ за протоколом Гемцитабін+Доцетаксел+Авастин з прогресією хвороби в печінці (10.2022). Виявлена мутація C-KIT, MET. Стан після лікування Пазопанібом (05-12.01.2023) з розвитком синдрому задньої зворотної енцефалопатії та позитивною динамікою за даними КТ.

01.2023 повторна біопсія печінки: ПГД - мтс лейоміосаркоми матки. Стан після 3х ХТ за протоколом Трабектидін з негативною динамікою (ПЕТ-КТ від 11.04.2023).

ПЕТ-КТ контроль від 13.05.2025

Референтні значення: медіастинальний пул - SUVmax 1,41; пул паренхіми печінки - SUVmax 1,99.

Контроль онкологічного захворювання

Шлунок: не розправлений, по малій кривизні зберігається гіподенсний аметаболический утвір, стабільними розмірами до 4,3х3,3х4,4 см (ax+sag), зі збільшенням кальцинатів в структурі.

Віддалене mts-поширення:

Печінка: вікарно збільшена, ККР правої частки до 18,7 см (13.05.2025 - ККР до 17,9 см), в паренхімі наявні аметаболическі утворення, гіподенсної щільності, стабільні в розмірах:

- Sg5/6/7/8 представлений масивним утвором до 14,4х10,4х14,1 см (ax+cor);
- Sg7 сателітний розміром до 1,0х1,0 см;
- Sg7/8 субкапсулярно розміром до 6,3х4,3 см;
- на межі Sg5/8 дрібний до 0,6х0,6 см;
- на межі Sg4a/7 до 0,6х0,6 см;
- на межі Sg2/3 утвір вздовж лівої портальної вени розміром 4,5х3,6 см;
- Sg1 розміром до 1,3х1,3 см;
- Sg4b дрібний до 0,4х0,4 см.

Матка: по передній стінці відмічається неоднорідний округлий утвір з кальцинатами в структурі умовним стабільним розміром до 6,8х5,5х4,8 см (ax+sag) - згідно анамнезу ймовірно лікована лейоміосаркома. По верхньому ребру наявний аметаболический утвір стабільним розміром до 4,6х3,7 см - для коректної оцінки доцільно дообстеження МРТ ОМТ з контрастуванням. Яєчники чітко не диференціюються - корелювати з даними УЗД.

Кістки без особливостей, кістковий мозок без підозрілого накопичення РФП.

Шия

Фізіологічний симетричний метаболізм РФП у ділянці піднебінних мигдаликів.

Ознак шийної метаболічно активної лімфаденопатії не виявлено.

Щитоподібна залоза не збільшена, структура звичайна, без підвищеної фіксації ФДГ.

Встановлена підшкірна порт-система на рівні правої підключичної ділянки, катетер проходить у верхню порожнисту вену, дистальний кінець розташований на рівні н/3 верхньої порожнистої вени.

Органи грудної порожнини

Грудні залози без патологічної фіксації ФДГ.

Ознак аксиллярної, медіастинальної та хілярної метаболічно активної лімфаденопатії не виявлено. Трахея та головні бронхи прохідні. Паренхіма легень звичайної пневматизації, інфільтративних чи об'ємних змін не виявлено. Одинокі дрібні були справа в SI субплеврально до 0,8см. Рідина у плевральних порожнинах відсутня.

Органи черевної порожнини та заочеревинного простору

Жовчний міхур не збільшений, стиснений прилеглою паренхімою печінки, вміст однорідної щільності, рентгенконтрастних конкрементів не виявлено. Підшлункова залоза нормотрофічна, контур чіткий фестончастий. Наднирники не збільшені, форма збережена. Нирки розташовані типово, їх паренхіма нормальної товщини. ЧМС, сечоводи звичайної конфігурації. Внутрішньочеревної та заочеревинної метаболічно активної лімфаденопатії не виявлено.

Органи малого тазу

Сечовий міхур нетуго наповнений, стінки не потовщені, додаткових утворень не містить. В Дугласовому просторі незначна кількість рідини. Тазової та пахової метаболічно активної лімфаденопатії не виявлено.

Висновок:

У порівнянні з ПЕТ-КТ від 13.05.2026 картина відомої гастроінтестинальної стромальної пухлини (GIST) шлунка та метастатичного ураження печінки без достовірної негативної динаміки.

Враховуючи гістологічно підтверджений GIST, що може характеризуватися відсутністю або варіабельною ФДГ-активністю, відсутністю вираженої метаболічної активності не виключає наявності резидуальної пухлинної тканини. Для коректної оцінки перебігу захворювання та подальшого контролю рекомендовано співставлення з даними КТ або МРТ з в/в контрастуванням.

Стабільний в динаміці кальцинований утвір тіла матки та аметаболічний утвір по верхньому ребру тіла матки - для коректної оцінки доцільно дообстеження МРТ ОМТ з контрастуванням.

Лікар рентгенолог: Закржевська К. П.

Керівник ВЦРХ, лікар-рентгенолог, лікар-радіолог

Кметюк Я.В.